TMO EPM · EPISÓDIO 94 · RESUMO DO JOURNAL CLUB

LMA do idoso: dá para ir além de aza + venetoclax?

Cladribina + citarabina em baixa dose + venetoclax alternando com azacitidina + venetoclax na LMA recém-diagnosticada — Kadia TM et al. (Am J Hematol 2026)

O estudo

Ensaio de **fase 2, braço único, aberto e de um só centro** (MD Anderson), em pacientes com LMA recém-diagnosticada com ≥60 anos ou inaptos à quimioterapia intensiva (após emenda de 2021, a partir de 50 anos). Desfecho primário: **remissão completa composta** (CRc = RC + RCi) nos 2 primeiros ciclos.

190	68 anos	13%	30 m
pacientes	mediana (47–84)	com ≥75 anos	seguimento mediano

O esquema

- **C1 · indução (28 dias):** cladribina 5 mg/m² IV D1–5 + citarabina 20 mg SC 2×/dia D1–10 + venetoclax D1–21 (rampa até 400 mg).
- **C2 · consolidação:** cladribina D1–3 + citarabina em baixa dose + venetoclax (7 dias se DRM negativa; 14 dias se DRM detectável).
- **C3–C4:** azacitidina 75 mg/m² D1–7 + venetoclax; depois, alternância entre os dois esquemas.
- **Transplante alogênico** oferecido aos elegíveis em primeira remissão (RC1).

Resultados principais

Desfecho	Resultado
CRc (RC + RCi) · desfecho primário	**84% (RC 73% + RCi 12%)**
DRM negativa entre os que responderam	**75%**
Mortalidade em 4 e 8 semanas	1% e 3%
Sobrevida global mediana	**52 meses**
Sobrevida global em 2 e 5 anos	60% e 45%
Sobrevida global em 2 anos: DRM negativa vs positiva	70% vs 38%
Transplante alogênico em RC1	43% (81 de 190)

No TP53 selvagem, CRc de 91% e DRM negativa em 77% dos que responderam. A maioria dos eventos adversos graus 3–4 foi infecciosa (neutropenia febril em 20%).

Transplante: o landmark

- Análise landmark em **4,1 meses** (mediana até o transplante), só entre os que entraram em remissão: sobrevida global em 5 anos de **78%** com transplante vs **36%** sem.
- Quem chega ao transplante já é selecionado (estava apto e seguia em remissão até lá): a diferença tem **viés de seleção** e não prova o efeito do transplante.

Leitura crítica

- **Braço único, sem comparador:** não há randomização contra azacitidina + venetoclax; toda comparação é indireta.
- **População mais jovem e apta que a do VIALE-A:** mediana de 68 vs 76 anos e muito mais transplante (43% vs 3 pacientes no VIALE-A). Os próprios autores pedem cautela ao comparar a sobrevida (52 vs 14,9 meses).
- **Peso do transplante:** parte da sobrevida longa vem de quem foi ao transplante em RC1, e o landmark não separa o efeito do esquema da seleção.
- **Centro único e de referência**, com internação de toda a indução e profilaxia anti-infecciosa: a reprodutibilidade fora desse contexto é incerta.

O que dá para levar

- No idoso ainda apto, somar cladribina e citarabina em baixa dose ao venetoclax deu remissão alta (CRc 84%) e DRM negativa frequente.
- Mortalidade precoce baixa (3% em 8 semanas), com toxicidade sobretudo infecciosa.
- O esquema abriu caminho para o transplante em RC1 em quase metade dos pacientes.
- Sem estudo randomizado, não substitui azacitidina + venetoclax para todos: é uma opção para o paciente selecionado.

Referência

Kadia TM, Bataller A, Bazinet A, et al. Cladribine With Low-Dose Cytarabine and Venetoclax Alternating With Azacitidine and Venetoclax for Newly Diagnosed Acute Myeloid Leukemia. Am J Hematol 2026. doi:10.1002/ajh.70328 · ClinicalTrials.gov NCT03586609.

Ouça o episódio 94

Apresentação: Luiza Miranda · Discussão: Eduardo Burlamaqui, Carol Marques, Rafael Faust, Lucas Salviano, Pedro Moraes e Vinícius Molla

▶ YouTube e 🎧 Spotify: **TMO EPM** · link na bio

📸 Instagram: **@tmoepm**

Material educativo, preparado a partir do artigo citado. Não substitui o julgamento clínico.